BONUS 3

Sjablonen voor casuspresentaties tijdens de visite

Opbouw van presentaties van 60 en 120 seconden, 8 sjablonen per type casus, kant-en-klare zinnen die je tijdens de visite helpen en 6 voorbeeldpresentaties van begin tot eind.

Inhoud

Hoe je deze sjablonen gebruikt

Hoofdstuk 1 · Presentatie van 60 seconden

Hoofdstuk 2 · Presentatie van 120 seconden

Hoofdstuk 3 · 8 sjablonen per type casus

Hoofdstuk 4 · Zinnen die werken tijdens de visite

Hoofdstuk 5 · 6 voorbeeldpresentaties

Hoofdstuk 6 · Laatste controle vóór de presentatie

Volgende stap

AAN DE SLAG

Hoe je deze sjablonen gebruikt

Een goede casuspresentatie is de hardop uitgesproken versie van een goed verslag: dezelfde volgorde, dezelfde helderheid.

> *Wat je tijdens de visite in de problemen brengt, is meestal geen gebrek aan kennis, maar dat je de volgorde kwijtraakt. Het sjabloon houdt de volgorde voor je vast; jij concentreert je op de bevinding.*

Bij de presentatie volg je dezelfde stappen als bij het verslaan, namelijk die **van de 4-stappenmethode** :

STAP	TEGENHANGER IN DE PRESENTATIE
1 · VOORBEREIDEN	Patiënt (leeftijd, geslacht), klinische vraag, onderzoek en protocol, technische kwaliteit.
2 · DOORLOPEN	De zin «Ik heb systematisch beoordeeld»; geef kort aan naar welke regio's je hebt gekeken.
3 · BESCHRIJVEN	Hoofdbevinding: juiste term, plaats, grootte, begrenzing; vergelijking met het eerdere onderzoek. Daarna de bijkomende bevindingen.
4 · SAMENVATTEN	Conclusie in één zin, differentiaaldiagnose, advies; aan wie en wanneer de spoedbevinding is gemeld.

Drie gouden regels

1. **Bewaar de conclusie niet voor het eind.** Noem zelfs in een presentatie van 60 seconden in de eerste zin de klinische vraag en in de laatste zin een duidelijke conclusie.
2. **Praat terwijl je het beeld laat zien.** Houd bij het beschrijven van de bevinding die coupe open op het scherm en wijs hem aan.
3. **Verzin niet wat je niet weet.** Zeggen «Hier ben ik niet zeker van, ik wil het graag samen met mijn supervisor beoordelen» is professioneel.

Oefening

Oefen elk sjabloon eerst drie keer hardop met een stopwatch. Schrijf je eigen tijd in het Oefenboek; het doel is de presentatie van 60 seconden in minder dan 60 seconden af te ronden.

DEEL 1

Presentatie van 60 seconden

Dienstoverdracht, visite op de gang, als iemand zegt «vertel het kort».

TIJD	WAT JE ZEGT
0–10 s · Identificatie en vraag	«[Leeftijd]-jarige [vrouw/man], [onderzoek] gemaakt wegens [klacht/klinische vraag].»
10–15 s · Techniek	«Onderzoek van diagnostische kwaliteit.» of «Beoordeling beperkt door [beperking].»
15–40 s · Hoofdbevinding	«In [plaats] is een [grootte], [begrenzing], [densiteit/signaal/echogeniciteit] [bevinding] te zien. Ten opzichte van het eerdere onderzoek [verandering].»
40–50 s · Bijkomend	«Bijkomende [bevinding] aanwezig / afwezig. Geen [belangrijke negatieve bevinding].»
50–60 s · Conclusie	«Concluderend passend bij [diagnose]; differentiaaldiagnostisch [1–2 diagnoses]. [Advies]. [Gemeld aan het klinische team].»

Het geheim van kort blijven

Noem in 60 seconden slechts één hoofdbevinding en hooguit twee belangrijke negatieve bevindingen. De rest licht je toe als er een vraag komt.

DEEL 2

Presentatie van 120 seconden

Ochtendvisite, casusbespreking, het moment waarop je supervisor zegt «vertel het vanaf het begin».

TIJD	WAT JE ZEGT
0–15 s · Identificatie en kliniek	Leeftijd, geslacht, klacht en duur, relevante voorgeschiedenis, klinische vraag.
15–25 s · Onderzoek en techniek	Modaliteit, contrast en fase (of sequenties), technische kwaliteit, beschikbaarheid van eerdere onderzoeken.
25–35 s · Doorlopen	«Ik heb [de regio's] systematisch beoordeeld.»
35–75 s · Hoofdbevinding	Volledige beschrijving met de juiste term: plaats, grootte (twee of drie vlakken), begrenzing, interne structuur, aankleuring; vergelijking.
75–90 s · Bijkomend en negatieven	Complicaties, bijkomende bevindingen, belangrijke negatieve bevindingen bij de klinische vraag.
90–110 s · Conclusie en differentiaaldiagnose	Conclusie in één zin; waarom je in de differentiaaldiagnose eerst hieraan denkt.
110–120 s · Advies en communicatie	Advies voor aanvullend onderzoek of follow-up; bij een spoedbevinding aan wie en wanneer die gemeld is.

Veelgemaakte fout

Bij een presentatie van 120 seconden gaat de meeste tijd verloren aan de doorloopzin. Som normale organen niet een voor een op: «Overige solide organen normaal» is genoeg; noem belangrijke negatieve bevindingen die bij de klinische vraag horen wel apart.

DEEL 3

8 sjablonen per type casus

Vul de open plekken in, verander de volgorde niet.

SJABLOON 1

Spoedbevinding (zoals bloeding, pneumothorax, vrij lucht)

1. «Ik begin met een spoedbevinding: [bevinding].»
2. Patiënt, klinische vraag, onderzoek.
3. Plaats, grootte en effect van de bevinding (zoals massa-effect, shift, collaps).
4. Complicaties en bijkomende bevindingen.
5. «Om [tijd] is [klinisch team/arts] geïnformeerd.»

SJABLOON 2

Normaal onderzoek

1. Patiënt, klinische vraag, onderzoek en technische kwaliteit.
2. «Bij de systematische beoordeling heb ik geen pathologische bevinding gezien.»
3. Belangrijke negatieve bevindingen gericht op de klinische vraag (bijv. «geen bloeding, massa-effect of fractuur»).
4. Vermeld een eventuele beperking van het onderzoek (bijv. vroege ischemie kan op een blanco CT onzichtbaar zijn).
5. Zo nodig een advies.

SJABLOON 3

Massa / laesie

1. Patiënt, klinische vraag, onderzoek en contrastfasen.
2. Plaats, grootte, begrenzing, interne structuur en aankleuringsgedrag van de laesie.
3. Relatie met aangrenzende structuren, tekenen van invasie.
4. Lymfeklieren en bevindingen op afstand.
5. Differentiaaldiagnose (te beginnen met de meest waarschijnlijke) en advies voor aanvullend onderzoek.

SJABLOON 4

Infectie / ontsteking

1. Patiënt, kliniek (koorts, pijn, laboratorium indien aanwezig), onderzoek.
2. Ontstekingsbevinding: plaats, uitbreiding.
3. Complicatie: abces, perforatie, obstructie, uitbreiding.
4. Differentiaaldiagnose.
5. Advies (is er een collectie geschikt voor drainage, is follow-up nodig).

SJABLOON 5

Trauma

1. Patiënt, traumamechanisme, onderzoek.
2. Het ernstigste letsel eerst (levensbedreigende bevinding).
3. Overige letsels, in systematische volgorde (van top tot teen of orgaan voor orgaan).
4. Belangrijke negatieve bevindingen (bijv. «geen actieve contrastextravasatie»).
5. Melding en advies.

SJABLOON 6

Follow-uponderzoek (vergelijkend)

1. Patiënt, bekende diagnose, datum en modaliteit van het eerdere onderzoek.
2. Huidige grootte van de bekende laesie en de verandering ten opzichte van eerder (met dezelfde methode gemeten).
3. Is er een nieuwe bevinding.
4. Algemene beoordeling: regressie, stabiel, progressie.
5. Advies.

SJABLOON 7

Controle van tube / katheter / hulpmiddel

1. Patiënt, onderzoek, gecontroleerd(e) hulpmiddel(en).
2. Waar ligt de tip van elk hulpmiddel; is die in de verwachte positie.
3. Complicatie door het hulpmiddel (pneumothorax, malpositie, knik).
4. Verandering ten opzichte van de vorige röntgenfoto.
5. Melding als de positie niet correct is.

SJABLOON 8

Toevalsbevinding

1. Eerst de klinische vraag en het antwoord daarop.
2. «Daarnaast werd als toevalsbevinding [bevinding] gezien.»
3. Beschrijving van de bevinding.
4. Advies op basis van de klinische betekenis en de follow-upaanpak die je afdeling gebruikt.
5. Was het op eerdere onderzoeken aanwezig.

DEEL 4

Zinnen die werken tijdens de visite

De juiste zin draagt de juiste mate van zekerheid.

SITUATIE	ZIN DIE JE KUNT GEBRUIKEN
Opening	«[Leeftijd]-jarige [vrouw/man]; [onderzoek] gemaakt wegens [klinische vraag].»
Technische beperking	«Beoordeling van [regio] beperkt door bewegingsartefacten.»
Vergelijking	«Vergeleken met het [onderzoek] van [datum] is [bevinding] in [grootte/aspect] [toegenomen/afgenomen/onveranderd].»
Geen eerder onderzoek	«Geen eerder onderzoek beschikbaar ter vergelijking.»
Hoge zekerheid	«Passend bij ....»
Gemiddelde zekerheid	«Pleit voor ...; differentiaaldiagnostisch kan aan ... gedacht worden.»
Lage zekerheid	«... kan niet worden uitgesloten.»
Belangrijke negatieve bevinding	«Wat de klinische vraag betreft geen ....»
Aanbeveling	«Ter beoordeling van ... kan evaluatie met [onderzoek] worden geadviseerd.»
Melding	«De bevinding is om [tijd] gedeeld met [betrokken arts].»
Een vraag waarop je het antwoord niet weet	«Hier ben ik niet zeker van; ik lees het na en kom er bij de visite van morgen op terug.»
Als je supervisor er anders over denkt	«Ik dacht vanwege ... aan ...; ik zou graag horen hoe jij de bevinding ... beoordeelt.»
Als de tijd dringt	«Kort: passend bij ..., gemeld aan .... Wil je dat ik de details laat zien?»
Afsluiting	«Concluderend ...; mijn advies is ....»

Uitdrukkingen om te vermijden

- «Volgens mij is er iets» — noem de bevinding en de plaats.
- «Lijkt normaal» — het is normaal, of noem de beperking.
- «Licht», «duidelijk» (zonder maat) — geef een maat.
- «Tumor» (zonder weefseldiagnose) — zeg «massa» of «massalaesie».
- Bij MRI «densiteit», bij echo «opaciteit» — gebruik de term die bij de modaliteit hoort.

HOOFDSTUK 5

6 voorbeeldpresentaties

Alle casussen zijn fictief; ze zijn alleen gemaakt om de opbouw van een presentatie te laten zien.

VOORBEELD 1 · 60 SECONDEN · SJABLOON 1

Hersen-CT na trauma

«Ik begin met een spoedbevinding: **acuut subduraal hematoom**.

Tweeënzeventigjarige man, blanco hersen-CT gemaakt wegens verminderd bewustzijn na een val thuis. Onderzoek van diagnostische kwaliteit.

Langs de linker frontopariëtale convexiteit is een sikkelvormige hyperdense extra-axiale collectie te zien, parallel aan de lamina interna van de schedel. Er is compressie van de linker laterale ventrikel en een middenlijnshift naar rechts.

Ik heb in het botvenster geen fractuur gezien. Geen bijkomende parenchymbloeding.

Concluderend passend bij een acuut subduraal hematoom met massa-effect. De bevinding is om 03.10 uur gedeeld met de SEH-arts.»

VOORBEELD 2 · 60 SECONDEN · SJABLOON 7

Thoraxfoto op de intensive care

«Vijfenzestigjarige vrouw, na intubatie bedside AP-thoraxfoto gemaakt ter controle van de tube. Lichte rotatie aanwezig, voldoende voor beoordeling.

De tip van de endotracheale tube ligt net boven het niveau van de carina; distaler dan de positie die onze afdeling verwacht. De tip van de centraalveneuze katheter via de rechter v. jugularis ligt ter hoogte van de vena cava superior. De maagsonde loopt tot onder het diafragma.

Geen pneumothorax. Geen nieuwe consolidatie ten opzichte van de vorige röntgenfoto.

Concluderend ligt de endotracheale tube distaal; beoordeling met het oog op terugtrekken wordt geadviseerd. Gemeld aan de intensivist.»

VOORBEELD 3 · 120 SECONDEN · SJABLOON 4

Pijn in de rechter onderbuik, abdomen-CT

«Achtentwintigjarige man, gepresenteerd met sinds twee dagen pijn in de rechter onderbuik en koorts; klinische vraag acute appendicitis. Abdomen-bekken-CT met contrast in portaal-veneuze fase gemaakt; geen eerder onderzoek. Onderzoek van diagnostische kwaliteit.

Ik heb het abdomen systematisch beoordeeld: vrij lucht, solide organen, darmen, vaten en bekken.

De appendix heeft een toegenomen diameter, een verdikte wand en wandaankleuring. In het lumen is een hyperdense focus passend bij een appendicoliet. Er is infiltratie van het periappendiculaire vetweefsel en een kleine hoeveelheid vrij vocht.

Ik heb geen collectie passend bij een abces en geen vrij lucht gezien. Wand van terminaal ileum en caecum normaal. Rechter nier en verloop van de ureter normaal, geen steen gezien.

Concluderend **ongecompliceerde acute appendicitis** passend. In de differentiaaldiagnose kan aan caecumdiverticulitis en terminale ileitis gedacht worden, maar de bevindingen zijn op de appendix gecentreerd.

De bevinding is gedeeld met de AIOS algemene chirurgie.»

VOORBEELD 4 · 120 SECONDEN · SJABLOON 3

Longmassa op thorax-CT

«Achtenzestigjarige man, gepresenteerd met een lange rookanamnese en sinds drie maanden hoesten; vanwege een opaciteit op de thoraxfoto is een thorax-CT met contrast gemaakt. Ter vergelijking is alleen een thoraxfoto van een maand geleden beschikbaar.

Ik heb een systematische beoordeling gedaan in het long- en mediastinumvenster.

In de rechter bovenkwab is een onregelmatige, gespiculeerde, heterogeen aankleurende solide massa te zien. De massa past bij de opaciteit op de röntgenfoto. Er is verdenking op uitbreiding naar de pleura; invasie van de thoraxwand is niet duidelijk.

Rechts hilair en laag paratracheaal zijn vergrote lymfeklieren aanwezig. In de linkerlong heb ik geen noduli gezien. Meegescande bijnieren en lever normaal; geen lytische botlaesies.

Concluderend **passend bij een primaire longmaligniteit** massa en hilaire-mediastinale lymfadenopathie. Verdere evaluatie wordt geadviseerd voor weefseldiagnose en stadiëring.

Ik wil het verslag graag samen met mijn supervisor definitief maken.»

VOORBEELD 5 · 60 SECONDEN · SJABLOON 2

Hoofdpijn, normale hersen-CT

«Veertigjarige vrouw, blanco hersen-CT gemaakt wegens hoofdpijn sinds een week. Onderzoek van diagnostische kwaliteit.

Bij de systematische beoordeling heb ik geen pathologische bevinding gezien.

Geen bloeding, massa-effect of middenlijnshift. Ventrikels en cisternen normaal. Grijze-wittestofdifferentiatie behouden. In het botvenster geen pathologie; sinussen belucht.

We weten dat een blanco CT beperkt is in het aantonen van sommige pathologieën; als de klinische verdenking blijft, kan aanvullend onderzoek samen met het klinische team overwogen worden.»

VOORBEELD 6 · 120 SECONDEN · SJABLOON 6

Follow-up van een leverlaesie

«Vijfenvijftigjarige vrouw, geopereerd wegens een colonmaligniteit; ter follow-up van een bekende solitaire leverlaesie abdomen-CT met contrast in portaal-veneuze fase gemaakt. Vergeleken met de CT van zes maanden geleden. Onderzoek van diagnostische kwaliteit.

Ik heb het abdomen systematisch beoordeeld.

De bekende hypodense laesie in de rechter leverkwab is in grootte afgenomen, gemeten met dezelfde methode en op dezelfde coupe als bij het eerdere onderzoek. Begrenzing en interne structuur van de laesie zijn niet duidelijk veranderd.

Ik heb in de lever geen nieuwe laesie gezien. Geen bevindingen passend bij lymfadenopathie, ascites of peritoneale implantaten. Geen duidelijke pathologie in het gebied van de anastomose. In de meegescande longbases geen noduli gezien.

Concluderend bij de bekende leverlaesie **afname in grootte**; geen nieuwe laesie. Ten opzichte van het eerdere onderzoek te beoordelen als passend bij respons op de behandeling.

Het follow-upinterval kan volgens het plan van het klinische team worden bepaald.»

HOOFDSTUK 6

Laatste controle vóór de presentatie

Neem vóór de visite 2 minuten.

Vóór elke presentatie

- [ ] Ik kan de leeftijd, het geslacht en de klinische vraag van de patiënt in één zin noemen.
- [ ] Mijn notitie over onderzoek, contrastfase of sequenties en technische kwaliteit staat klaar.
- [ ] Ik heb het eerdere onderzoek geopend en vergeleken (of genoteerd dat het er niet is).
- [ ] De coupe die de hoofdbevinding laat zien, staat klaar op het scherm.
- [ ] Voor de hoofdbevinding gebruik ik de juiste term (densiteit / signaal / echogeniciteit).
- [ ] Ik heb minstens twee belangrijke negatieve bevindingen die bij de klinische vraag horen.
- [ ] Mijn conclusie in één zin en mijn differentiaaldiagnose staan klaar.
- [ ] Bij een spoedbevinding weet ik aan wie en wanneer die gemeld is.
- [ ] Ik heb de presentatie één keer in stilte met een stopwatch geoefend.

Gouden regel

Het enige wat je supervisor van de visite onthoudt, is je laatste zin. Schrijf je conclusiezin vooraf op en zeg hem woord voor woord.

Uitsluitend voor educatieve doeleinden. Dit materiaal vervangt de opleiding, supervisie, het klinisch oordeel of het verslag van een specialist niet.

Volgende stap

Kies nu een casus uit de 100 praktijkcasussen en houd met het passende sjabloon uit Sjabloon 1–8 een presentatie van 60 seconden, met een stopwatch.

Om de vragen die je bij de presentatie kunt krijgen vooraf te oefenen **300 vragen voor de visite en het mondeling examen** en ga daarheen.